

TEMA 1.5 • CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA

Furúnculos, Abscesos, Flegmones, Panadizos, Onicocriptosis

PERFIL EUNACOM 4.01.1.017

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

(Nota: Aunque el código EUNACOM se refiere a patología anorrectal, aplican los principios de supuraciones, abscesos cutáneos y partes blandas)

Infecciones Locales: Furúnculos, Abscesos y Flegmones

En la evaluación de medicina general, es clave distinguir el espectro de la patología inflamatorio-infecciosa de partes blandas y sus diferencias esenciales en el manejo.

1. Furúnculo

- **Clínica:** Infección focal de un folículo piloso (foliculitis), pero de gran envergadura. Se visualiza como una pústula inflamatoria centrada en un pelo. - **Microbiología Clásica:** *Staphylococcus aureus*. - **Complicaciones:** - Absedación (formación de pus contenida). - **Ántrax Estafilocócico:** Confluencia grave y profunda de múltiples furúnculos sucesivos (ej. nuca, espalda, barba). - **Tratamiento:** Observación y calor local en etapas iniciales. Si hay riesgo o ántrax se prescribe **Antibióticos (anti-S. aureus)**. Si se encuentra netamente abscedado, se realiza un drenaje simple. El ántrax severo exige debridamiento quirúrgico amplio más antibióticos.

2. Absceso

- **Clínica:** Edema e induración focalizada aguda, dolorosa y eritematosa. Su signo clásico es la **fluctuación** a la palpación (sensación de líquido a tensión) por una colección franca de pus en un tercer espacio no anatómico. Puede asociar fiebre. - **Diagnóstico:** Clínico si es superficial. Exige confirmación mediante imágenes (Ecografía o TAC) si la región es profunda (ej. retroperitoneal, pélvico o subdiafragmático). - **Tratamiento:** Siempre es el **Drenaje Quirúrgico** (evacuar la colección) con o sin colocación sistemática de antibióticos accesorios dependiendo de la agresividad, pero el drenaje alivia de inmediato la fisiopatología.

3. Flegmón

- **Clínica:** Gran edema infeccioso (celulitis extensa) con signos inflamatorios rotundos. Pese a que parece un absceso, la diferencia fundamental es que **NO posee una colección líquida o tercer espacio (no fluctúa)**; la infección está difusa intercelularmente. - **Diagnóstico:** Exige imágenes ecográficas para descartar activamente la microabsedación. - **Tratamiento:** **SOLO Antibióticos** (ej. ceftriaxona o tratamiento empírico enfocado).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Un flegmón **NUNCA DEBE DRENARSE**. Un corte profundo en un flegmón estéril de pus desencadenará un sangrado agresivo innecesario, al disrumpir un lecho únicamente edematoso inflamatorio vascularizado sin cavidad que evacuar.

Infecciones Digitales y Ungueales

4. Panadizo (Paroniquia)

- **Clínica:** Inflamación micro-bacteriana de la falange distal, frecuentemente originada de los bordes laterales y proximales de la uña (infección paraungueal). Viene acompañado de eritema reactivo severo y aumento de volumen turgente con pus local. - **Microbiología Clásica:** *S. aureus* o *S. pyogenes* (Cocos Gram Positivos). - **Tratamiento:** Curación local focal, asociado netamente

a erradicación microbiológica de Gram Positivos empleando empíricamente **Cloxacilina o Cefadroxilo**.

5. Onicocriptosis (Uña Encarnada)

- **Clínica:** La uña perfora mecánicamente los bordes subyacentes e interfiere lateralmente (escondiéndose) contra el pliegue del tejido de las uñas, gatillando de esta forma una respuesta nociva perenne, originando una paroniquia constante dolorosa en los dedos de forma persistente. - **Prevención:** Uso de corte estricto lateral **recto** (nunca circular la uña; las esquinas deben sobrevivir su límite anatómico). - **Manejo:** - Si es leve, curaciones locales aisladas. - Si es grave con sobreinfecciones severas, recidivante o forma tejido de granulación persistente, abordaje quirúrgico definitivo: **Matricectomía Química con Fenol** (se secciona la base del borde y luego se calcina/quema la matriz radicular lateral para inhibir crecimiento futuro).

EUNACOM CRITERIOS

Ante una onicocriptosis masiva purulenta, la eliminación total del manto y de la placa ungueal (Onisectomía) ya **NO** es la elección preferencial en relación a la intervención aislada sobre la matriz lateral, ya que esta última resuelve el crecimiento errante recidivante focal sin secuelear radicalmente el área fisiológica.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un paciente de treinta años consulta por aumento de volumen doloroso en la región cervical posterior, fluctuante, con eritema y salida de pus al presionarlo. El diagnóstico es absceso. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Furúnculos, Abscesos, Flegmones, Panadizos, Onicocriptosis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El furúnculo es infección del folículo piloso por *Staphylococcus aureus*; el ántrax estafilocócico es su complicación grave con confluencia de varios folículos y requiere cirugía en pabellón.
- El absceso es aumento de volumen fluctuante con pus y se trata con drenaje quirúrgico; los profundos requieren imagen diagnóstica.
- El flegmón es edema infeccioso sin colección de pus y se trata solo con antibióticos, nunca con drenaje porque no hay colección.
- El panadizo o paroniquia es infección del pliegue periungual por gram positivos y se trata con cloxacilina o cefalexina.
- La onicocriptosis o uña encarnada se previene con corte recto de uñas y en casos graves se trata con matricectomía química con fenol.
- La matricectomía química con fenol es el tratamiento de elección de la onicocriptosis grave o recurrente, no la onicectomía total.
- La diferencia clave entre absceso y flegmón es la presencia de colección de pus: el absceso se drena, el flegmón solo se trata con antibióticos.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (FURÚNCULOS, ABSCESOS, FLEGMONES, PANADIZOS, ONICOCRIPTOSIS)**PREGUNTA 1**

Un paciente de treinta años consulta por aumento de volumen doloroso en la región cervical posterior, fluctuante, con eritema y salida de pus al presionarlo. El diagnóstico es absceso. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

- A)** Solo antibióticos orales por siete días
- B)** Drenaje quirúrgico más antibióticos
- C)** Solo observación porque puede reabsorberse
- D)** Antibióticos endovenosos sin drenaje
- E)** Compresas calientes y AINEs hasta que drene solo

PREGUNTA 2

Un paciente de veinticinco años presenta aumento de volumen doloroso, eritema y edema en la región del masetero. La ecografía no muestra colección de pus. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?

- A)** Absceso, drenaje quirúrgico más antibióticos
- B)** Flegmón, antibióticos sin drenaje
- C)** Flegmón, drenaje quirúrgico urgente
- D)** Furúnculo, antibióticos y drenaje en box
- E)** Absceso subperióstico, TAC urgente y cirugía

PREGUNTA 3

Una paciente de veintidós años consulta por dolor e inflamación recurrente en el primer dedo del pie por uña encarnada. Ya fue drenada dos veces. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- A)** Onicectomía total, extirpación completa de la uña
- B)** Antibióticos prolongados y curaciones
- C)** Matricectomía química con fenol
- D)** Observación y educación sobre corte de uñas
- E)** Amputación distal del dedo

RESUMEN: FURÚNCULOS, ABSCESOS, FLEGMONES, PANADIZOS, ONICOCRIPTOSIS

El furúnculo es una infección del folículo piloso por *Staphylococcus aureus*, más grande que la foliculitis. Se puede observar, tratar con antibióticos o drenar en el box si está abscedado. Su complicación grave es el ántrax estafilocócico, que confluye varios folículos y requiere antibiótico más cirugía en pabellón. El absceso es un aumento de volumen fluctuante con pus, signos inflamatorios y posible fiebre. El diagnóstico es clínico para abscesos superficiales; los profundos requieren imagen. El tratamiento siempre es drenaje quirúrgico más antibióticos. El flegmón tiene clínica similar al absceso pero sin colección de pus, solo edema infeccioso. El diagnóstico requiere imagen para diferenciarlo del absceso porque el tratamiento cambia: el flegmón se trata solo con antibióticos, sin drenaje, ya que si se incide solo se produce hemorragia. El panadizo es la inflamación de los dedos, especialmente la infección paraungial o paroniquia, causada por *Staphylococcus aureus* o *Streptococcus pyogenes*, y se trata con cloxacilina o cefalexina. La onicocriptosis o uña encarnada se presenta con dolor y paroniquia. Su prevención es cortarse las uñas con corte recto. El tratamiento de elección hoy en día es la matricectomía química con fenol, que remueve un fragmento de la base de la uña y quema para evitar recidiva. La onicectomía total ya no es de elección.